

Procedimiento para la Vigilancia Epidemiológica de las Arbovirosis

PC04:2026 · Tegucigalpa M.D.C. · Enero, 2026 · Honduras C.A.

Aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 03-DGN-2026 por la Dra. Xochilt María Chavez,
Directora General de Normalización, el 19 de enero de 2026.



Introducción

Las arbovirosis son un problema de salud pública mundial. Su control es difícil debido a factores ambientales, sociales y económicos que favorecen la adaptación y expansión de vectores en regiones tropicales, subtropicales e incluso templadas.

177,209

Casos sospechosos

Dengue en 2024, superando los 132,143 de 2019

185

Fallecimientos

Certificados por dengue en 2024; tasa de letalidad de 0.10

1,791

Tasa de incidencia

Por 100,000 habitantes en 2024, la más alta en la historia del país

El año 2024 marcó un punto de inflexión al registrarse una de las epidemias de dengue más intensas, obligando al gobierno a declarar una **Emergencia Sanitaria Nacional**. Aunque en los últimos 5 años no se reporta circulación de Chikungunya ni Zika, las condiciones tropicales y la alta densidad urbana mantienen el riesgo latente.

Objeto y Campo de Aplicación

Objeto

Establecer el procedimiento de vigilancia epidemiológica de las arbovirosis en el **Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)**, permitiendo la recolección, análisis, interpretación y difusión de datos para la toma oportuna de decisiones.

Campo de Aplicación

De aplicación **obligatoria** para todo el personal de salud en establecimientos públicos y no públicos a nivel nacional. Incluye:

- Personal médico y de enfermería
- Microbiólogos y técnicos de laboratorio
- Epidemiólogos nacionales y regionales
- Entomólogos y Técnicos en Salud Ambiental (TSA)
- Promotores de Atención Primaria en Salud (PAPS)

Términos y Definiciones Clave



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE SALUD

Arbovirosis

Enfermedades causadas por virus transmitidos por artrópodos hematófagos (mosquitos, garrapatas, jejenes). Incluyen dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y oropouche, entre otras.

Dengue (DSSA / DCSA / DG)

Causado por serotipos DEN-1 a DEN-4. Se clasifica en: Sin Signos de Alarma (DSSA), Con Signos de Alarma (DCSA) y Dengue Grave (DG), según manifestaciones clínicas.

Vigilancia Epidemiológica

Recolección sistemática y continua de datos sobre un problema de salud; su análisis, interpretación y uso en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud.

Brote / Periodo Epidémico

Aparición repentina de casos que exceden lo esperado en una comunidad o área geográfica. El **periodo interepidémico** es la etapa sin brote activo pero sin endemicidad establecida.

Vigilancia Entomológica

Monitoreo de hábitos, distribución y densidad de vectores transmisores de arbovirosis.

Vigilancia Viroológica

Seguimiento de agentes infecciosos para detección temprana de brotes.

Vigilancia Genómica

Monitoreo de cambios en el material genético de patógenos para identificar variantes.

Responsabilidades por Nivel



Epidemiólogo Nacional (UVS)

- Monitorear diariamente los datos en el SNVS y evaluar el riesgo epidemiológico.
- Monitoreo de la vigilancia epidemiológica laboratorial articulada.
- Monitoreo y notificación de fallecimientos.
- Difundir semanalmente el boletín nacional de arbovirosis
- Alertar tempranamente el riesgo de brotes en regiones sanitarias.
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas a epidemiólogos regionales
- Elaborar informes técnicos trimestrales y anuales



Epidemiólogo Regional / Hospital

- Monitoreo diario de los datos regionales reportados en el SNVS.
- Verificar calidad de datos en el SNVS y corregir fichas en ≤ 24 horas.
- Udentificación, análisis y sectorización de casos sospechosos.
- Orientación, asesoramiento e investigación de campo.
- Monitorear muestreo: 10–30% de DSSA; 100% de DCSA, DG, fallecimientos y embarazadas
- Notificar fallecimientos sospechosos a la UVS en ≤ 24 horas con documentación correspondiente.
- Coordinación de los Comité de Mortalidad.
- Elaborar semanalmente el boletín epidemiológico regional



Personal de Atención Médica: Médico, Lic/Aux. de enfermería

- Aplicar criterios de definición de casos sospechosos
- Llenar correctamente la ficha epidemiológica en el SNVS (≤ 3 días)
- Indicar toma de muestra: 30% interepidémico / 10% epidémico de DSSA
- Notificar fallecimientos sospechosos al epidemiólogo regional en ≤ 24 horas con documentación correspondiente.

Responsabilidades por niveles Laboratorio

Laboratorio de Nivel Central/ Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud / Sección de Virología.

1. Gestión Normativa y Operativa

- Establece directrices nacionales y actualiza flujogramas de diagnóstico.
- Coordina la recepción de muestras bajo estrictos protocolos de bioseguridad.



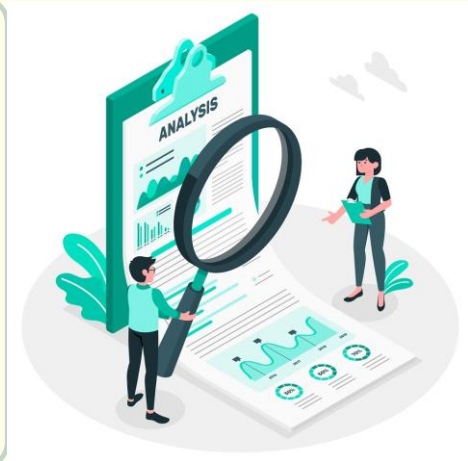
2. Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstica

- Análisis de muestras y registro sistemático en el SNVS.
- Identificación de serotipos, genotipos y variantes (vigilancia genómica).
- -Realización de diagnósticos diferenciales de arbovirosis.
- Confirmar casos de arbovirosis emergentes o reemergentes



3. Análisis de Datos e Informes

- Consolidación de datos de la red de laboratorios.
- Generación de boletines semanales, informes mensuales y reportes técnicos de secuenciación.



4. Estrategia de Muestreo Crítico

- Muestreo selectivo (10% - 30%): En casos de Dengue sin signos de alarma (DSSA) en zonas con transmisión establecida.
- Muestreo total (100%): Casos graves (DG), con signos de alarma (DCSA), fallecidos, embarazadas y Fiebre Amarilla.



Responsabilidades por niveles Laboratorio

Profesional de Laboratorio de la Región Sanitaria

1. Gestión de Muestras y Calidad

- **Recepción y Cotejo:** Aplicación estricta de protocolos del Laboratorio Nacional de Virología (LNV).
- **Control de Calidad:** Verificación del correcto llenado de fichas epidemiológicas y estado de la muestra.
- **Estandarización:** Garantizar precisión y puntualidad siguiendo las técnicas oficiales.



2. Procesamiento y Registro

- **Análisis Técnico:** Procesamiento de muestras bajo rigurosas medidas de bioseguridad.
- **Sistematización:** Registro obligatorio y sistemático de resultados en el SNVS.



3. Vigilancia y Notificación Inmediata

- **Alertas Tempranas:** Reporte inmediato al LNV de casos positivos de arbovirosis emergentes o reemergentes.
- **Comunicación Oficial:** Notificar a las autoridades tras la confirmación de nuevos virus.



4. Análisis y Fortalecimiento

- **Información Estratégica:** Generar datos para la vigilancia epidemiológica regional.
- **Reporte Semanal:** Informar la situación laboratorial al Epidemiólogo regional.
- **Capacitación:** Mejora continua del recurso humano en técnicas de vigilancia.



Responsabilidades por niveles Laboratorio

Profesional de Laboratorio de los Establecimientos de Salud

1. Validación y Definición de Caso

- **Cotejo Digital y Físico:** Verificación de la solicitud en el SNVS contra la ficha epidemiológica física.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurar que el paciente cumpla estrictamente con las definiciones de caso antes de proceder a tomar la muestra.



2. Obtención de la Muestra (Suero)

- **Procedimiento Estandarizado:** Toma de muestra de suero siguiendo los manuales oficiales de la Secretaría de Salud.
- **Bioseguridad:** Aplicación rigurosa del manual de Bioseguridad y Biocustodia para garantizar la seguridad del personal y del paciente.

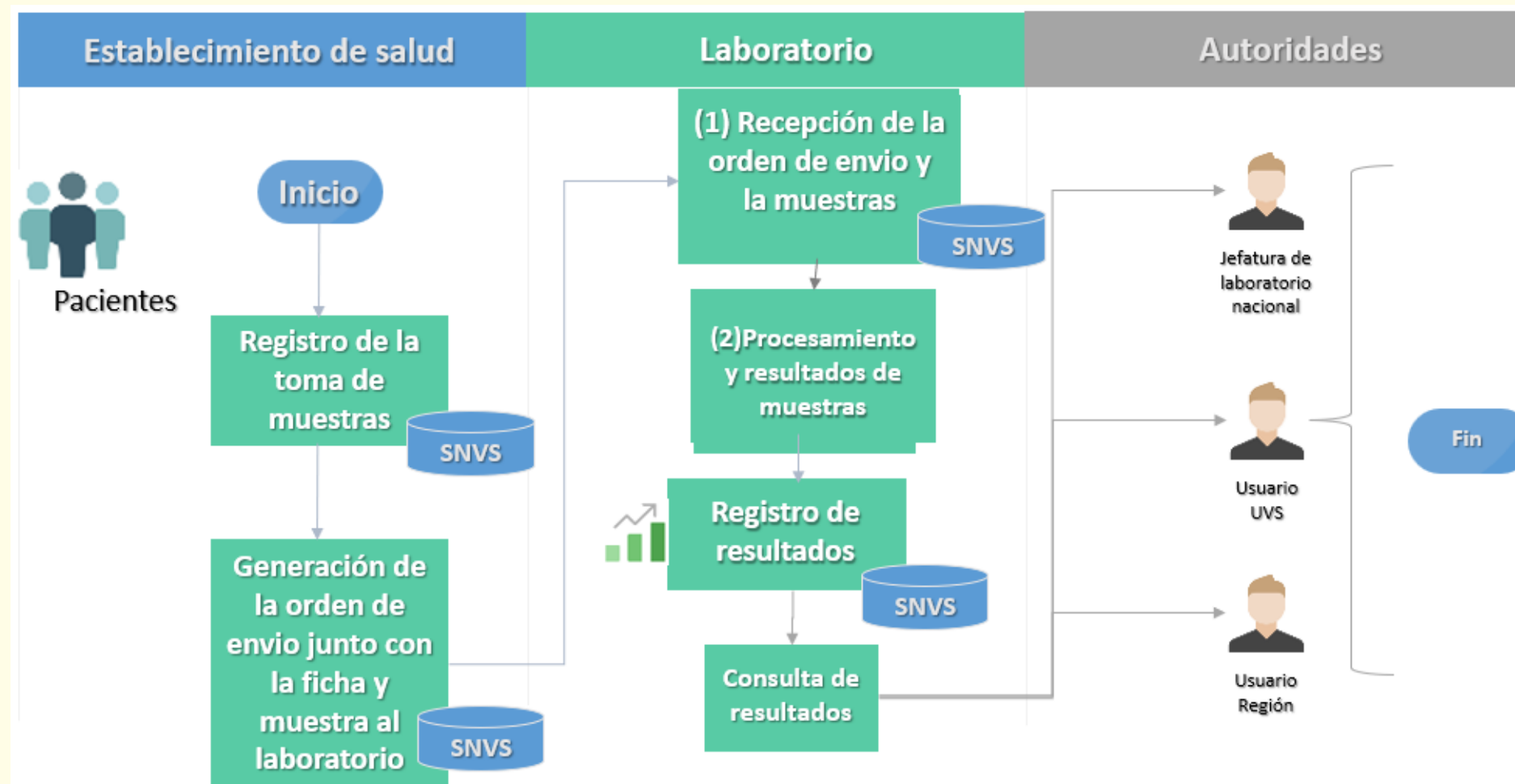


3. Gestión y Envío Regional

- **Rotulado Correcto:** Identificación precisa de la muestra para evitar errores de trazabilidad.
- **Transporte Seguro:** Envío al Laboratorio Regional cumpliendo con las normas de manejo y transporte de muestras biológicas.



Flujo del proceso general- Vigilancia de Arbovirosis

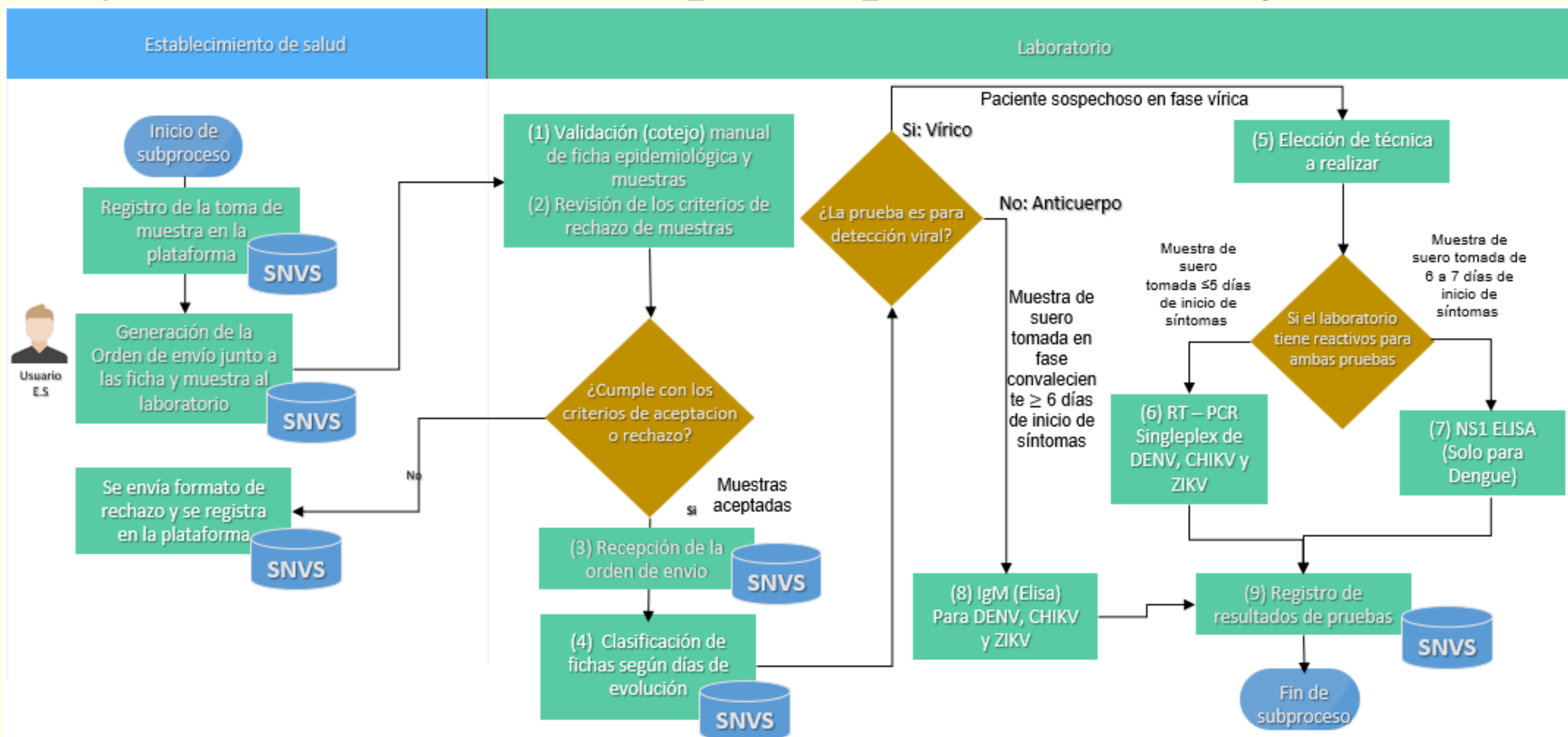


El profesional de salud identifica el caso sospechoso, llena la ficha en el SNVS y solicita muestra según el periodo epidemiológico. La técnica diagnóstica se determina por los días de evolución de la enfermedad, garantizando la oportunidad del resultado laboratorial.

Días de evolución	Técnica	Diagnóstico	Arbovirosis
0 – 5 días	RT-PCR	Confirmado	Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarilla y otras
0 – 7 días	ELISA-NS1	Confirmado	Dengue
≥ 6 – 15 días	ELISA-IgM	Probable	Dengue, Chikungunya, Zika



Flujo de la muestra: Recepción, procesamiento y resultados



Nota: Se realiza el procesamiento de otros Arbovirus (Zika, Chikungunya, Mayaro, Oropouche y Fiebre Amarilla) al igual que el diagnóstico diferencial del 10% de las muestras negativas de dengue de manera mensual

Responsabilidades: Vigilancia Entomológica



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE SALUD

Vigilancia Entomológica

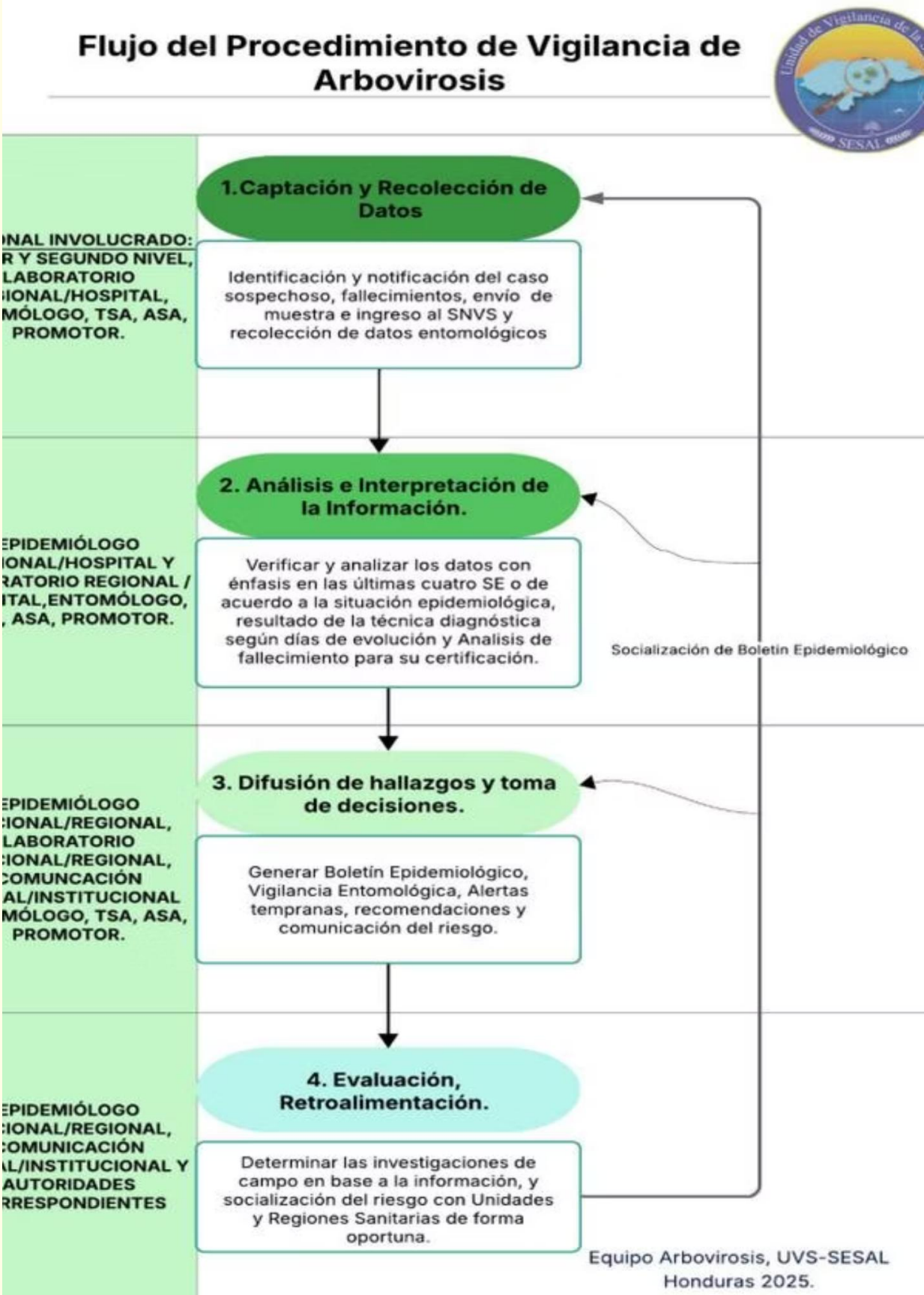
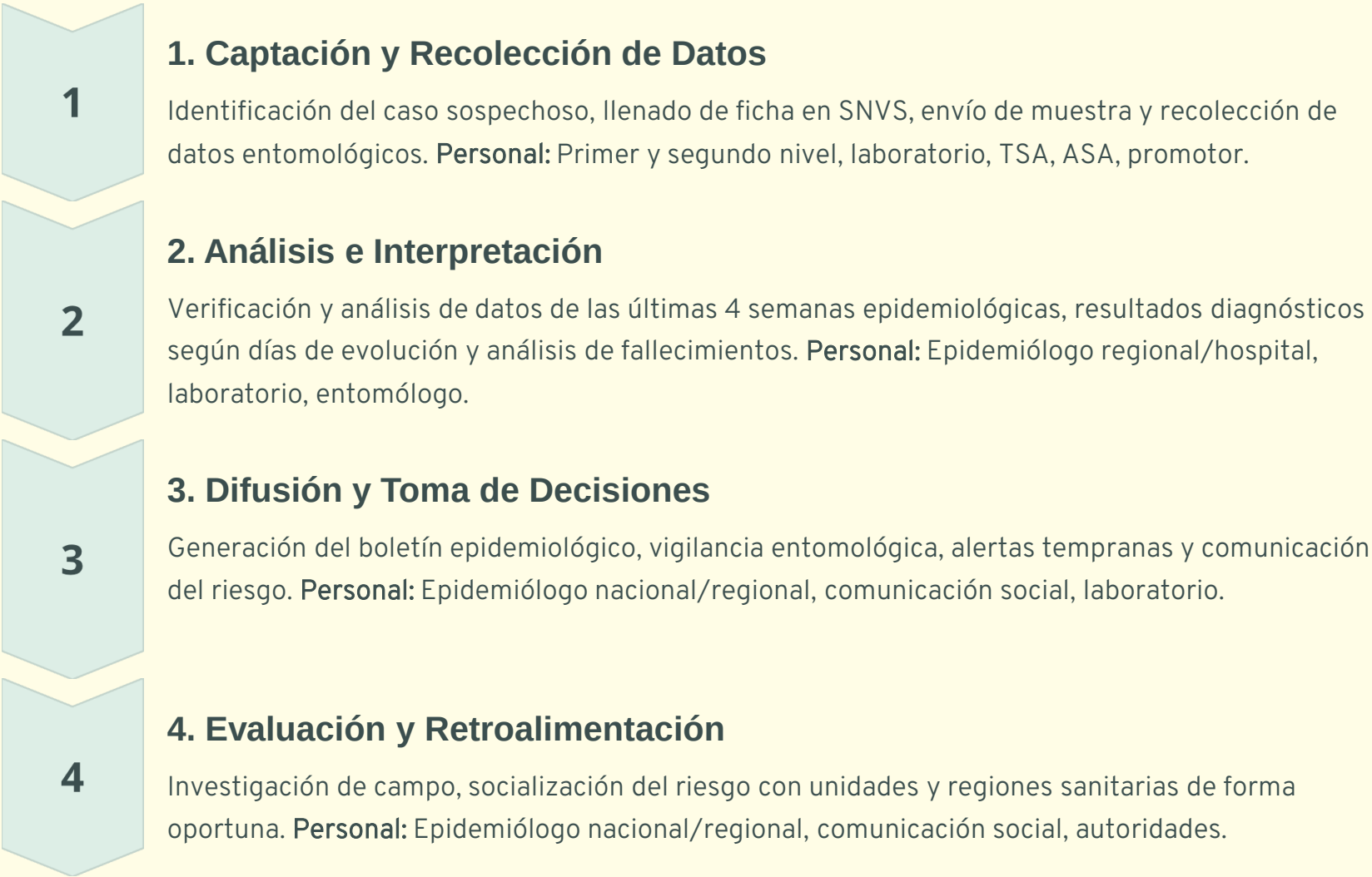
Entomólogo, TSA, ASA, PAPS

- Determinar presencia, densidad poblacional y distribución geográfica de especies entomológicas
- Monitorear la susceptibilidad a insecticidas de forma rutinaria
- Evaluar la efectividad de las intervenciones de control vectorial
- Calcular indicadores clave: **Índice de Breteau** e **Índice de Casa Positiva**

Comunicación Social/Institucional

- Comunicar el riesgo a la población según el escenario epidemiológico mediante vocería oficial, charlas y difusión de boletines epidemiológicos a la población general.

Flujo del Procedimiento de Vigilancia de Arbovirosis



7.2.2 Análisis e Interpretación de la Información

01	02	03
Control de calidad del dato	Análisis de las últimas 4 semanas epidemiológicas	Comité de Mortalidad
El epidemiólogo regional coteja diariamente los datos del SNVS. Si hay discrepancias, notifica al responsable para corrección de la ficha digital.	Se sectoriza la información para brindar asesoramiento técnico al nivel operativo. Se monitorea la vigilancia laboral: 10–30% de DSSA y 100% de DCSA, DG, fallecimientos y embarazadas.	El comité emite el informe de análisis en un lapso de 3 semanas epidemiológicas . El TSA/ASA/PAPS realiza la autopsia verbal en las primeras 72 horas del fallecimiento.
04	05	
Alertas y boletines epidemiológicos	Actualización de planes estratégicos	
El epidemiólogo regional y nacional elaboran boletines semanales y alertan sobre riesgo de brotes a autoridades: Secretaría de Salud, viceministros, direcciones y jefaturas.	El epidemiólogo nacional actualiza los planes de vigilancia según el periodo epidémico o interepidémico y elabora informes técnicos trimestrales y anuales.	



7.2.3 Difusión de Hallazgos y Toma de Decisiones



Boletín Epidemiológico Regional

El epidemiólogo regional difunde semanalmente el boletín a los establecimientos de salud y a la UVS de nivel central, con base en los datos del SNVS.



Boletín Nacional de Arbovirosis

El epidemiólogo nacional elabora semanalmente el boletín nacional y lo difunde a la Secretaría de Salud, viceministros, direcciones y jefaturas.



Alertas Tempranas de Brote

El epidemiólogo regional y nacional emiten informes técnicos alertando el riesgo de brote epidémico a la Jefatura Regional, UVS y Programa PAETV.



Actualización de Planes Estratégicos

Se actualizan los planes de vigilancia epidemiológica según los periodos interepidémico y epidémico, y se elaboran informes técnicos trimestrales y anuales.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE SALUD

7.2.4 Evaluación y Retroalimentación

Investigación de Campo y Control Vectorial

El epidemiólogo regional/hospital, con base en el SNVS, coordina la investigación de campo y las intervenciones de control vectorial. El TSA/ASA/entomólogo realiza encuestas entomológicas rutinarias para calcular el **Índice de Breteau** y el **Índice de Casa Positiva**.

Monitoreo de Insecticidas y Capacitación

Se monitorea rutinariamente la susceptibilidad a insecticidas, se evalúan nuevas moléculas y se ajustan las estrategias de control según el Manual de Atención Integral de Vectores vigente. El epidemiólogo nacional fortalece las capacidades técnicas de los epidemiólogos regionales para mejorar la respuesta en vigilancia epidemiológica.

Anexos: Instrumentos de Vigilancia

Anexo A — Ficha Epidemiológica de Arbovirosis

Herramienta oficial para el registro de casos sospechosos de dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y oropouche. Incluye datos del paciente, antecedentes epidemiológicos, datos clínicos, sospecha clínica, manejo, laboratorio y clasificación epidemiológica.



Anexo B — Informe del Comité de Mortalidad

Documento para el análisis de fallecimientos por arbovirosis. Incluye resumen de autopsia verbal y documental, diagnósticos de ingreso, resultados laboratoriales y conclusión del comité: fallecimiento certificado por dengue o descartado.

Anexo C — Personal del Comité de Mortalidad

Comité Regional: Jefatura regional, epidemiólogo, redes integradas, vigilancia normativa, planeamiento y médico con experiencia clínica.

Comité Hospitalario: Director, epidemiólogo, subdirectores, jefes de gestión clínica, enfermería y médico especialista.

1. DEFINICIÓN DE CASO: ver al reverso.
2. UNIDAD NOTIFICADORA

Establecimiento: _____ Departamento: _____
Municipio: _____ Persona que llena la ficha: _____
Persona que digita la ficha en el SNVS: _____

3. INFORMACIÓN DEL PACIENTE

DNI/Pasaporte / Expediente: _____ Nombre completo: _____
Nacionalidad: _____ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Edad: _____ Etnia: _____
Sexo: Mujer ____ Hombre ____
Domicilio actual: Departamento: _____ Municipio: _____
Dirección completa: _____
Tel. fijo/Celular: _____ Lugar de Trabajo: _____

4. ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS

Antecedentes:
Viajó a algún lugar en las últimas 2 semanas. Si ____ No ____ Paciente referido. Si ____ No ____
Tratamiento recibido: _____
Condiciones coexistentes:
Embarazo: _____ Semanas de gestación: _____ Diabetes: _____ Hipertensión Arterial: _____ Insuficiencia Renal: _____
Otro (especifique): _____

5. DATOS CLÍNICOS

Fecha de inicio de fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____ Días de evolución: _____ Semana Epidemiológica: _____

	Si	No		Si	No		Si	No		Si	No	Otros	Si	No
Fiebre $\geq 38^{\circ}$			Dolor abdominal intenso			Metrorragia			Presión de pulso $<20\text{mmHg}$			Prurito		
Nauseas			Vómitos persistentes			Letargo			Extremidades frías			Escalofríos		
Vómito			Asciditis			Irritabilidad			Rigidez de nuca			Fotofobia		
Cefalea			Derrame pleural			Hipotensión postural			Otros			Mareos		
Mialgias			Derrame Pericárdico			Hepatomegalia ($>2\text{cm}$)			Artritis			Diarrea		
Artralgia			Epistaxis			Choque			Adenopatías					
Petequias			Gingivorragia			Dificultad Respiratoria			Parálisis flácida					
Dolor retro ocular			Hematemesis			Pulso débil o indetectable			Conjuntivitis no purulenta					
Exantema			Melena			Lenado Capilar >3 segundos								

Temperatura: _____ $^{\circ}\text{C}$ P.A: Sistólica: _____ Diastólica: _____ PAM: _____ Pulso: _____ /min. FR: _____ /min

6. SOSPECHA CLÍNICA (indicar sospecha clínica según orden de prioridad (1,2,3))

Dengue: _____ Clasificación clínica: Dengue sin signos de alarma: _____ Dengue con signos de alarma: _____ Dengue grave: _____
Chikungunya: _____ Zika: _____ Fiebre amarilla: _____ Oropouche: _____ Otras (especifique): _____

7. MANEJO DEL PACIENTE

Manejo: Ambulatorio: Si ____ No ____

Hospitalizado: Si ____ No ____ Fecha de ingreso: ____/____/____ Fecha de egreso: ____/____/____ Condición de Egreso: Alta ____ Fugado ____ Fallecido: ____
Fecha de la defunción: ____/____/____ *Adjuntar documentación del fallecimiento

8. LABORATORIO (uso exclusivo del Laboratorio).

Toma de muestra: Si ____ No ____

Fecha de toma: ____/____/____

Tipo de muestra: Suero ____

Fecha de recepción: ____/____/____

Días de evolución de toma: _____

Serotipo de Dengue: _____

DEN-1: _____ DEN-2: _____

DEN-3: _____ DEN-4: _____

9. CLASIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

Sospechoso: _____ Confirmado: _____ *Ver definiciones al reverso.



SECRETARÍA DE SALUD

UNIDAD DE VIGILANCIA DE SALUD

INFORME DE ANÁLISIS COMITÉ DE MORTALIDAD POR ARBOVIROSIS



Región Sanitaria: _____ Registro N°: _____

Reunidos el día de hoy: _____ del año _____, este comité de mortalidad analizó el siguiente caso de defunción:

Nombre del fallecido (Siglas)	Edad	Sexo		Lugar de residencia actual
		H	M*	

*De ser **Mujer** determine los antecedentes Gineco Obstétricos:

Embarazada		G	P	A	C
No	Si				

*Completar anexo 9 del Instrumento para el Análisis de casos de muertes maternas de la Guía para la vigilancia de la mortalidad materna en Honduras.

Lugar de Defunción	Fecha de Defunción	Hora de Ingreso	Hora de Defunción

Se reporta a UVS- AVRA de nivel central con:

Ficha epidemiológica	
Constancia de defunción	

Distancia del establecimiento de salud más cercano:

0 a 30 min.	
30 min. A 60 min.	
>1 hora	

Resumen de Autopsia Verbal:

Resumen Autopsia Documental:



Referencia:

El paciente fue referido: Si* ____ No ____

*Nombre del establecimiento del que fue referido: _____

Fecha de referencia: _____

Visitó Establecimiento Privado: Si* ____ No ____ *Nombre de la clínica: _____

Vacuna de Dengue: Si ____ No ____

Dosis	Primera	Segunda
Fecha de vacunación		

Diagnósticos de Ingreso:

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

Resultado laboratorial:

Prueba de Laboratorio	Fecha	(+)	(-)
RT-PCR			
NS1(EIUSA)			
IgM (EIUSA)			

Diagnósticos concluyentes del fallecimiento según comité:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Conclusión del Fallecimiento:

Fallecimiento Certificado Por Dengue ☐

Descartado ☐

Nombre y Firma de Participantes en la discusión del Fallecimiento:

Responsables Comité Mortalidad Regional (Ver integrantes adjunto)

Nombre Completo	Unidad	Firma

Responsables Comité Mortalidad Hospital/Establecimiento privado (Ver integrantes adjunto)

Nombre Completo	Unidad	Firma



Equipo Técnico Elaborador

Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS)

- Dra. Sigris Andrea Romero – Punto Focal Nacional de Dengue
- Dr. Pedro Fernando Medina Pineda – Técnico UVS
- Dr. Juan Jesús Llambias Peláez – Técnico UVS
- Lic. Oscar Rolando Urrutia – Coordinador Vigilancia Entomológica

Laboratorio Nacional de Virología (LNV)

- Dra. Rosario del Carmen Figueroa Tercero – Técnico Sección Virología

Dirección General de Normalización

- Dra. Georgina Waleska Sarmiento Soler
- Dra. Jennifer Jackelyn Urquía Lazo

Expertos OPS

- Dra. Aída Soto – Asesora Vigilancia de la Salud en Honduras
- Dra. Anabelle Alfaro – Asesora Grupo Técnico Internacional de Arbovirosis
- Dra. Rosa Elena Mejía – Asesora Nacional Proyecto Pandémico